

ROTEIRO DE CONTEÚDO MÍNIMO PARA LAUDOS, RELATÓRIOS E PRONTUÁRIOS MÉDICOS

BPC/LOAS Deficiente • Aposentadoria PCD • Auxílio por Incapacidade Temporária (Previdenciária ou Acidentária) • Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Invalidez) • Auxílio Acidentário

Documentos médicos necessários para análise do direito:

- **ATESTADO:** Documento curto, que indica um fato pontual, e demonstra a necessidade de afastamento por determinado número de dias. Serve como indício da incapacidade em uma data específica, mas não descreve o quadro nem sua evolução.
- **RELATÓRIO MÉDICO:** Documento detalhado, onde o médico descreve o histórico do paciente, desde o seu diagnóstico, data de início da doença, tratamentos realizados, evolução, limitações funcionais e prognóstico.
- **LAUDO:** Documento conclusivo, cuja principal função é a comunicação de condições de saúde e de necessidades a essas relacionadas, com base em exame clínico e complementares. É um resumo clínico e técnico sobre a condição do paciente.
- **PRONTUÁRIO:** Registro completo e cronológico de todos os atendimentos do paciente em um hospital, UBS, CAPS ou clínica, com anotações de consultas, exames, prescrições e internações. Comprova a continuidade do tratamento, o que é essencial para demonstrar a data de início da doença ou da incapacidade.

Tipos de benefícios e informações principais:

1. BPC/LOAS Deficiente

O que precisa ser demonstrado:

- Impedimento de longo prazo de **natureza física, mental, intelectual ou sensorial**, com **duração mínima de 2 (dois) anos**, que, em interação com uma ou mais barreiras, obstrua a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Deve constar no laudo ou no relatório médico:

- Natureza do impedimento:** Problema de saúde de ordem física, mental, intelectual ou sensorial.
- Data de início do impedimento,** de forma mais precisa possível, e se ele persiste até a data atual.
- Prognóstico:** Estimativa de duração ou declaração de que o quadro é permanente, irreversível ou sem previsão de melhora.

A regra de deficiência é de 2 anos, desde o início do impedimento até a data prevista para sua cessação.

OBS: Para um processo ajuizado em 2026, qualquer combinação serve, desde que a soma alcance 24 meses. Exemplos:

- Impedimento iniciado em 2024 e ainda presente; OU
- Diagnóstico iniciado em 2026 com prognóstico de duração até no mínimo 2028;

d. Limitações funcionais concretas: O que a pessoa não consegue fazer, como: locomover-se, comunicar-se, realizar auto-cuidado, trabalhar, estudar ou conviver socialmente.

Exemplo prático: Pessoa com problema ortopédico, que não consegue locomover-se com facilidade, tem dificuldade de percorrer longas distâncias e permanecer por longos períodos em pé (impossibilitada, portanto, de exercer atividades profissionais).

e. Barreiras enfrentadas: Dependência de terceiros, necessidade de acompanhamento contínuo, dificuldade de acesso a transporte ou tratamento.

Frases-chave:

"Impedimento de longo prazo, com duração superior a 2 anos";

"Faz tratamento desde [prazo mínimo de 2 anos]";

"Prognóstico de término do tratamento em, no mínimo, 2 anos";

"Impossibilidade total";

"Impossibilidade permanente";

"Necessita de auxílio de terceiros para [descrever atividades]".

Para casos de menores de 16 anos: Em vez de incapacidade laboral, o laudo deve descrever o impacto na participação social e nas atividades compatíveis com a idade (vida social, acesso a educação e saúde), bem como a necessidade de cuidados que limitem a atividade laboral dos responsáveis. Exemplos: relatórios escolares, de terapias (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia) e do CAPS.

2. Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (por idade ou tempo de contribuição)

O que precisa ser demonstrado: Condição de pessoa com deficiência, com impedimento de longo prazo, durante os períodos contributivos e o respectivo grau da doença (leve, moderado ou grave).

OBS: Para esse benefício, a pessoa deve ter trabalhado com a deficiência, portanto, **o laudo não deve afirmar incapacidade total para o trabalho**.

Ele deve constar que "exerce/exerceu atividade laboral com limitações, adaptações ou maior esforço em razão da deficiência".

Informações importantes: Tipo de deficiência e CID relacionado.

Deve constar no laudo ou no relatório médico:

- a. **Data de início da deficiência:** É essencial, pois define quais períodos contam como tempo na condição de PCD. Se a deficiência for congênita, isso deve constar expressamente.
- b. **Informação se o quadro é permanente ou transitório.**
- c. **Grau da deficiência (leve, moderado ou grave),** se o profissional puder estimá-lo, com a respectiva justificativa.
- d. **Evolução ao longo do tempo:** Se houve agravamento, com as datas descritas, pois o grau pode variar entre períodos.
- e. **Limitações funcionais nos seguintes domínios:** Sensorial, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação/trabalho/vida econômica, socialização e vida comunitária.
- f. **Adaptações e barreiras no trabalho:** Uso de órteses ou próteses, dependência de ajuda, necessidade de adaptações no posto de trabalho, dificuldades de deslocamento etc.

OBS: Laudos e prontuários antigos, contemporâneos aos vínculos, são muito valiosos: exames, atestados, internações e documentos de cotas PCD do empregador.

Documentos da empresa também ajudam: Contratação por cota, ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) e exame admissional mencionando a deficiência.

3. Auxílio por Incapacidade Temporária

O que precisa ser demonstrado: Incapacidade total e temporária para o trabalho ou a atividade habitual por período **superior a 15 dias**, ainda que decorrente de afastamentos não necessariamente consecutivos dentro do mesmo mês, com qualidade de segurado e carência na data de início da incapacidade (DII).

OBS: A soma de vários atestados médicos variados **só é permitida se houver correlação clínica** entre as doenças diagnosticadas dentro de um período de até 60 dias.

Deve constar no laudo ou relatório médico:

- a. **Profissão ou atividade habitual do paciente,** pois a incapacidade é aferida em relação a essa atividade.
- b. **Data de início da doença e data de início da incapacidade.**

c. Correlação entre a doença e a atividade exercida, por que a condição impede aquela função específica (exemplo: "não pode realizar esforço físico, carregar peso ou permanecer em pé por longos períodos").

d. Tempo estimado de afastamento ou data provável de recuperação.

e. Tratamento em curso e informação sobre aguardo de cirurgia, procedimento ou exame, com a respectiva previsão.

Frases-chave:

"Incapacitado de forma total e temporária para o exercício de sua atividade profissional";

"Necessita de afastamento por período estimado de [X]".

"Realizou o procedimento [X] e necessita de afastamento pelo tempo estimado de [X]"

4. Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Invalidez)

O que precisa ser demonstrado: Incapacidade total e permanente para qualquer atividade que garanta a subsistência, com impossibilidade de reabilitação profissional.

Deve constar no laudo ou relatório médico:

a. Incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral.

b. Impossibilidade de reabilitação profissional para outra atividade que garanta a subsistência.

c. Prognóstico: Se o quadro é irreversível, crônico, progressivo, degenerativo ou sem perspectiva de melhora, conforme o caso.

d. Histórico de tratamentos já realizados (cirurgias, medicações, terapias).

e. Condições pessoais: Idade do paciente, escolaridade e histórico profissional (exemplo: sempre exerceu a função [X], realizando atividades braçais e que demandam esforço físico).

Frases-chave

"Incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa".

"Insuscetível de reabilitação profissional".

"Sem prognóstico de melhora".

5. Auxílio-Acidente

O que precisa ser demonstrado: Sequela definitiva, decorrente de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, que reduza a capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Isso se aplica a acidentes de trabalho, de trajeto, de trânsito ou domésticos, e também a doenças ocupacionais, que são equiparadas a acidente de trabalho.

A sequela deve estar presente após a consolidação das lesões.

OBS: Não é exigida incapacidade total. Basta a redução da capacidade ou a necessidade de maior esforço para exercer a mesma atividade. Por isso, o laudo não precisa afirmar que o paciente está totalmente incapacitado, pois o benefício tem natureza indenizatória e pode ser recebido junto com o salário.

Informações importantes: Tipo de lesão, CID relacionado e data do acidente.

Deve constar no laudo ou no relatório médico:

a. Descrição do acidente: Data, circunstância (acidente de trabalho, de trajeto, de trânsito) e lesão sofrida.

b. Tratamentos realizados: Cirurgias, imobilizações, fisioterapia e período de afastamento.

c. Consolidação das lesões.

d. Sequela definitiva: Descrição objetiva da sequela. Exemplos: perda de mobilidade de articulação, redução de força, amputação, encurtamento de membro, perda auditiva ou de visão.

e. Nexo causal: Relação entre o acidente e a sequela apresentada. No casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional, deve constar a relação com a atividade profissional.

f. Repercussão da sequela na atividade laboral: Por que a sequela reduz a capacidade para aquela função específica. Exemplo: Pedreiro que, após fratura no punho, perdeu parte da força e da mobilidade da mão. Consegue trabalhar, mas com dificuldade para carregar peso e manusear ferramentas, exigindo maior esforço.

Frases-chave

"Apresenta sequela definitiva decorrente do acidente ocorrido em [data]";

"Lesões consolidadas";

"Redução permanente da capacidade para o exercício de sua atividade habitual de [X]";

"Necessita de maior esforço para o desempenho da mesma atividade";

"Sequela com nexo causal com o acidente sofrido".

IMPORTANTE! Documentos complementares: CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), boletim de ocorrência, ficha de atendimento do pronto-socorro, prontuário da internação ou cirurgia e exames de imagem da época do acidente e posteriores à alta.